

INDICADO POR: Internet
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

MARCOS VENICIO MENDONÇA

IDADE: 57 PESO: 136 ALTURA: 186 PROFISSÃO: Empregado (Ex militar) Aposentado
SINTOMAS: Roncos, sonolência diurna

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Spirolactona / medicamentos HAS

MÉDICO: Dra. Lilian Christian (Otorino)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 20h-20:30h

HORA QUE DORME: 22:30-23h HORA QUE ACORDA: 5:30-6h

COCHILHO: (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N (X) EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (2) X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇOA: (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 12 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2 X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 96cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 86,2cm SPO2: 55%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (6) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

14/11/24 Avaliação Localização

21/11/24 P_{media}: 13,1 cmH₂O
TAH = 3,6 cmH₂O
m de uso: 5h 27'
fuga: 62ul/m
Oriento que seria ideal mudar p/ BiPAP por um mês para regular e solicitar ficar c/ equipamento mais 15 dias

Matarha

11/12/24 P = 13,4 cmH₂O
 IAH = 2,5 e/h
 fuga: 8,0 l/m
 mde ura: 5h23' Oriente fazer Biologix
 Natadha

07/03/25 Realizo a leitura do Biologix (resultado)
 com pete
 P = 13,4 cmH₂O Bem adaptado
 IAH = 1,6 e/h
 mde ura: 7h
 fuga: 23,4 l/m Natadha

26/05/25 P = 13,4 cmH₂O Bem adaptado.
 IAH = 1,1 e/h
 mde ura = 7h20'
 fuga = 23 l/min
 Jai compan Zaiuo
 Selvia

Nome: MARCOS VENÍCIO MENDONÇA

Data de Nascimento: 7-5-1967

IMC: 37,00

Sexo: Masculino

Data do exame: 30-08-2021

Peso: 130 kg

Altura: 1,85 m

Médico: DRA. LILIAN CHRYSTIAN G.

MARSON

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-08-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 430,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 6,5 e 114,5 minutos. O tempo total de sono foi de 561,5, eficiência de 80,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 79,0%; estágio N3: 0%; sono REM: 17,3%. O índice de despertares foi de 59,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 86,2/hora, sendo elas 73 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 83% e mínima de 55%, permanecendo 72,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 42 - 76 bpm e NREM de 39 - 80 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (1), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. estágio N3 do sono NREM ausente, porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 86,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=55%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Obs.: não houve atividade em EMG sugestiva de bruxismo e não associado a eventos respiratórios.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa

Médecina do Sono

CRM 57157